



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : على حسن موسى هنية
المحافظة : الفيوم الحى / المدينة : سنورس
رقم البطاقة : 28304182300611 رقم التليفون :
العمر (تاريخ الميلاد) : 18-04-1983 المهنة : بدون عمل
العنوان : ي
تاريخ تسجيل الإستمارة : 03-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان البنكرياس
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان البنكرياس
خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي محوسب مع صبغة للرقبة والصدر
والبطن والحوض [11128]
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.
تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: علي حسن موسى هنية National ID: 28304182300611	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

A patient of pancreatic cancer for Contrast-enhanced CT scan of the neck, chest, abdomen, and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



على
حسن موسى هيبه
الخرق
مركز اطنسا - القيوم

١٩٨٣/٠٤/١٨

٢٨٣٠٤١٨٢٣٠٠٦١١

II5667277

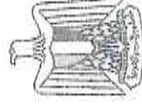


٢٠٢٠/٠٢ ٢٨٣٠٤١٨٢٣٠٠٦١١

حاصل على دبلوم صنايع

متزوج مسلم ذكر

البطاقة سارية حتى ١/٣١/٢٠٢٧



The General Organization For teaching Hospital
And institutes
Ahmed Maher Teaching Hospital
Advanced Gastrointestinal Endoscopy Unit



الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
مستشفى احمد ماهر التعليمي
وحده منظار الجهاز الهضمي المتقدمه

EUS Report

Name: علي حسن موسى ID: 22694
Date: Saturday 19, September 2026 Age: 43

Referring Doctor

Dear Prof.

Thank you for referring the case.

Indications

CBD stricture

Medications

GA

Instrument

Olympus CV 190

Procedure Technique

A physical exam was performed. Informed consent obtained. The patient was connected to monitoring devices. After adequate sedation was achieved the patient was intubated. Following examination, the patient was subsequently extubated and transported to the recovery area in satisfactory condition

Findings

EUS of the pancreas showed a 25x35 mm hypoechoic lesion seen at the head of the pancreas (FNB using 22G needle was retrieved for HPE). MPD was of average caliber. CBD stent was mildly dilated with plastic stent. A 20*15mm portahepatis LN was noted. CA, SMA, SA and SV were free. EUS of the left lobe of the liver showed no HFL or IHBR dilatation. Normal mediastinum.

Conclusion

Pancreatic mass (as described -biopsied)

Recommendation

waiting biopsy result

EndoScopist

Ahmed Heiba, MD

مستشفى الندى

قسم منظار الجهاز الهضمي

ERCP

التاريخ : ٢٠٢٦/٨ / ١٤

السن : ٤٣ سنة

الاسم : علي حسن موسى

Indication: Obstructive Jaundice.

Medication: GA

Findings:

- A precut was done.
- Cannulation of the CBD using a sphincterotome.
- Cholangiography showed dilated CBD & IHBRs with distal CBD stricture.
- Sphincterotomy was done followed application of 7 cm 10 f plastic stent with adequate drainage.
- For CT abdomen with Oral & IV contrast (Pancreatic protocol).
- EUS assessment.
- Follow up after 3 months.

Endoscopist,

DR. Mohamed Omar Idris, MD.

Dr. Ahmed El-Habashi, MD, PhD, FIAC
Professor of Pathology:
NCI, Cairo University
International Board of Cytopathology
Fellow of International Academy of Cytology
Fellow Tulane Univ. Hospital, USA
Fellow Groningen Univ. Hospital, Holland

أ.د. أحمد حسين الحبشي
الباثولوجي - المعهد القومي للأورام - جامعة القاهرة
بورد السيقيباتولوجي الدولي
زميل الأكاديمية الدولية للسيقيباتولوجي
زميل جامعة تولين- نيو اورليانز- امريكا
زميل جامعة غرونينجن- هولندا

Patient Name: علي حسن موسى

Age: 43 Y-O

Clinical History: Pancreatic head mass

Nature of Specimen: Pancreatic head mass EUS-FNB

Referring Prof. Doctor: Ahmed Heiba

Date of Specimen Receiving: 19/9/2026

Gender: Male

Date of Reporting: 23/9/2026

Surgical Pathology/ Cytopathology Report

Gross Description:

Pancreatic head mass, EUS FNB: Recived hemorrhagic fragments of tan tissue in formalin cores preparation. Toto in one cassette.

Microscopic Description:

Sections showed cellular material featuring hemorrhagic background entangling atypical predominant large sized epithelial cuboidal to columnar tumor cells existed in clusters, acinar patterns, cords and separate forms displaying moderate manifested by high N/C ratio, anisonucleosis, irregular nuclear membrane, prominent nucleoli and conspicuous eosinophilic cytoplasm with squamous metaplastic changes. The stroma showed desmoplasia and necroinflammatory debris.

Diagnosis

Pancreatic Head Mass, EUS-FNB (Cores):

Adenocarcinoma, Grade II-III, consistent with pancreatic duct origin.

AME

Ahmed El-Habashi, MD, FIA

10 شارع صبري أبو علم بجوار وزارة الأوقاف - باب الشرق - القاهرة

تليفون : 23929937 موبايل : 0166736608

E-Mail: elhabashiahmed@yahoo.com



Name: Ali Hassan Mousa
Referring prof : Loteif Mostafa
Date : August 13, 2026 .

مركز أمان
AMAN CENTER
للأشعة التشخيصية و العلاجية

Pelvi abdominal Ultra sonography examination revealed:

Liver:

- Mild enlarged measuring about (16.5 cm) with homogenous echo pattern and smooth outline.
- No focal lesions
- Moderate to marked dilated I.H.B.Rs.
- Portal vein is patent and not dilated.
- Distended gallbladder showing mud with no sizable stone.
- C.B.D is seen dilated reaching 12 mm with proximal to fairly defined hypoechoic pancreatic head mass lesion measuring about 3.5 x 3cm.
- Few enlarged peri-pancreatic lymph nodes the largest measuring 2 x1cm

Spleen:

- Average size measuring about (9.2 cm) with homogeneous echo pattern showing no focal lesions.

Kidneys:-

- **Rt. Kidney:** Average size with normal parenchymal thickness and echo pattern, It shows no stones, masses, cysts or backpressure changes.
- **Lt. Kidney:** Average size with normal parenchymal thickness and echo pattern, It shows no stones, masses, cysts or backpressure changes.

U.B.:

- Moderate filling of the bladder with fair wall thickness showing no stones or focal masses.

Prostate :

- Average size measuring about (+/- 25 gm) with and fair outline

Others:

- Diffuse colonic gaseous distension.
- No ascites.

Opinion:

- Suspicious pancreatic head mass lesion with subsequent CBD and IHBR dilatation as described for further MRCP/Tripahsic CT pancreatic protocol assessment.
- Few prominent peri-pancreatic lymph node.
- Mild hepatomegaly.

Much obliged
Dr Mustafa Mamdouh

اطسا - مفارق اطسا - موقف الفيوم - اعلى محل ضي القمر ☎ 01055182122
الفرق بدري - بجوار الموقف - مول ابو زايد ☎ 01006367904

EUS Report

Name: علي حسن موسى

ID: 22694

Date: Saturday 19, September 2026

Age: 43

Referring Doctor

Dear Prof.

Thank you for referring the case.

Indications

CBD stricture

Medications

GA

Instrument

Olympus CV 190

Procedure Technique

A physical exam was performed. Informed consent obtained. The patient was connected to monitoring devices. After adequate sedation was achieved the patient was intubated. Following examination, the patient was subsequently extubated and transported to the recovery area in satisfactory condition

Findings

EUS of the pancreas showed a 25x35 mm hypoechoic lesion seen at the head of the pancreas (FNB using 22G needle was retrieved for HPE). MPD was of average caliber. CBD stent was mildly dilated with plastic stent. A 20*15mm portahepatis LN was noted. CA, SMA, SA and SV were free. EUS of the left lobe of the liver showed no HFL or IHBR dilatation. Normal mediastinum.

Conclusion

Pancreatic mass (as described -biopsied)

Recommendation

waiting biopsy result

EndoScopist

Ahmed Heiba, MD

Patient Name: ALI HASSAN MOUSSA

Ref. By Prof. Dr: LOTAIIF MOSTAFA

Age: 43years

NA

31-08-2026

" CT - Report "**Dear Professor,****Multislice Triphasic CT scan of the abdomen and pelvis after oral and IV contrast media revealed:**

- Average hepatic size showing homogenous texture. No focal lesions with internal CBD slightly slipped stent and prominent central IHBR. No definite pathologically enhancing lesions.
- Normal CT appearance of the spleen showing homogenous texture. No focal lesions seen.
- Normal form and size of the suprarenal glands, with no retroperitoneal masses.
- Enlarged pancreatic head 3 x 5 cm showing ill defined hypodense focal area at the anterior aspect, also no dilatation of the pancreatic duct.
- Normal contrast excretion and filtration from both kidneys, no stones, masses, or back pressure manifestations.
- No sizable abdominal or retroperitoneal lymphadenopathy.
- No ascitis or intraperitoneal fluid collection.
- Normal CT appearance of the pelvic organs with well distended urinary bladder showing regular outline, normal wall thickness, with no filling defects, or diverticulum formation.
- Clear lower thoracic cuts.

OPINION

Enlarged pancreatic head with hypodense pancreatic head focal lesion possibly neoplastic for MRI evaluation

internal CBD slightly slipped stent and prominent central IHBR.

Signature

DR. Marian Fayek, MD.

Revised by ;

Your sincerely
DR. KHALED EL-SHANTALY,
 Prof-Radiodiagnosis ,



الفيوم : المسلة - ش. النبوي المهندس - أمام مستشفى الندي

٠١٠٦٢٠٧٠٠١٢ - ٠٨٤/٢١٥٠٨١١ - ٠٨٤/٢١٥٠٥١٦ ©